O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI
SHAHRISABZ ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

MA’RUZA MATNI

“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli

A-1: Shifoxona va poliklinika ko‘z kabinetining tuzilishi va jihozlanishi. Oftalmologik kasalliklar bilan og‘rigan bemorlarni tekshirish va davolashda hamshiralik parvarishi

Ko‘rsatkich	Ma’lumot
Mutaxassislik kodi va nomi	50910203 – Hamshiralik ishi
Kvalifikatsiya	Umumiy amaliyot hamshirasi
Mashg‘ulot turi va soati	Amaliy mashg‘ulot, 4 soat (160 daqiqa)
Ta’lim tili	O‘zbek tili
Muallif	Axmedova Roxila – Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi

Mashg‘ulot maqsadi

O‘quvchilarda shifoxona va poliklinika ko‘z kabinetining tuzilishi va jihozlanishi, oftalmologik bemorlarni tekshirish usullari hamda davolashda hamshiralik parvarishi bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish.

Reja

1. Shifoxona va poliklinika ko‘z kabinetining tuzilishi va jihozlanishi
2. Oftalmologik bemorlarni tekshirish usullari va hamshiraning ishtiroki
3. Davolashda hamshiralik parvarishi: amaliy muolajalar

O‘qitish natijalari (o‘quvchi mashg‘ulot yakunida):

- Ko‘z kabinetining xonalari va jihozlarini sanab beradi.
- E. B. Rabkin polixromatik jadvali asosida rang ko‘rishni tekshiradi.
- Tashqi ko‘rik, yon yoritish va palpator tonometriya tartibini tushuntiradi.
- Kon’yunktiva bo‘shlig‘iga tomchi dori tomizadi, qovoq orqasiga malham qo‘yadi.

Tayanch so‘zlar

ko‘z kabineti, yorug‘ xona, qorong‘i xona, yon yoritish, o‘tuvchi nur, oftalmoskopiya, tonometriya, perimetriya, Rabkin jadvali, monokulyar bog‘lam.

1. Shifoxona va poliklinika ko‘z kabinetining tuzilishi va jihozlanishi

Aholiga oftalmologik yordam poliklinikaning ko‘z kabineti, oilaviy shifokor punkti, ko‘z kasalliklari bo‘limi va ixtisoslashgan markazlarda ko‘rsatiladi. Ko‘z kabineti birlamchi bo‘g‘indagi asosiy tuzilma bo‘lib, unda bemorlar qabul qilinadi, ko‘rish funksiyalari tekshiriladi, oddiy muolajalar bajariladi, dispanser kuzatuvi olib boriladi va profilaktik ishlar tashkil etiladi.

Ko‘z tekshiruvi uchun ikkita xona ajratiladi: yorug‘ xona va qorong‘i xona. Yorug‘ xonaning o‘lchami uzunligi 5 m, eni 3,5 m ga yaqin bo‘lib, unda bemor qabul qilinadi va ko‘rish o‘tkirligi 5 m masofadan tekshiriladi. Xona kaltaroq bo‘lsa, jadval qarshisiga ko‘zgu o‘rnatiladi. Qorong‘i xona uzunligi 3,5 m, eni 1,5 m atrofida bo‘ladi. Uning devorlari to‘q rangga bo‘yaladi, derazasi qalin parda bilan yopiladi. Bu xonada yon yoritish, o‘tuvchi nur bilan tekshirish, oftalmoskopiya va biomikroskopiya bajariladi, chunki ko‘z ichidagi tuzilmalar qorong‘ida aniq ko‘rinadi.

Kabinet jihozlari

Guruh	Jihozlar	Vazifasi
Ko‘rish funksiyalari	Rot apparati, Sivtsev–Golovin va Orlova jadvallari, Rabkin jadvallari, perimetr, adaptometr	Ko‘rish o‘tkirligi, rang ko‘rish, ko‘ruv maydoni, qorong‘ilik adaptatsiyasi
Refraksiya	Sinov linzalari to‘plami, sinov gardishi, skiaskopik lineykalar, avtorefraktometr	Refraksiyani aniqlash, ko‘zoynak tanlash
Ko‘z ichini ko‘rish	Stol lampasi, 13 dioptriyali lupa, ko‘zgu oftalmoskop, elektr oftalmoskop, tirqishli lampa	Oldingi bo‘lim va ko‘z tubini tekshirish
Bosim	Maklakov tonometri, bo‘yoq, spirt, tonometr maydonchalari	Ko‘z ichi bosimini o‘lchash
Muolaja	Steril pipetkalar, shisha tayoqchalar, tomchi dorilar, malhamlar, steril doka, bint, ko‘z vannachasi	Muolajalarni bajarish

Muolaja stoli har kuni tozalanadi va steril o‘ram bilan yopiladi. Tomchi dorilar nomi, foizi va tayyorlangan sanasi yozilgan idishlarda saqlanadi. Tashqi ishlatish uchun va kuchli ta’sir etuvchi dorilar alohida joylashtiriladi. Pipetka va shisha tayoqchalar har bir bemor uchun alohida steril holda ishlatiladi. Tonometr maydonchalari har bir o‘lchashdan keyin spirt bilan artiladi va quritiladi. Kabinetda birinchi yordam to‘plami, jumladan ko‘zni yuvish vositalari, steril bog‘lam materiallari va og‘riqsizlantiruvchi tomchilar doimo tayyor turadi.

Hamshiraning kabinetdagi vazifalari

- ish boshlanishidan oldin xona, jihoz va dorilarni tayyorlash, muddatini tekshirish;
- bemorlarni navbat bilan qabul qilish, tibbiy hujjatni rasmiylashtirish;
- ko‘rish o‘tkirligi, rang ko‘rish va ko‘z ichi bosimini aniqlashda ishtirok etish;
- tomchi tomizish, malham qo‘yish, ko‘zni yuvish, bog‘lam qo‘yish;
- dispanser guruhlaridagi bemorlarni (glaukoma, miopiya, katarakta, diabetik retinopatiya) chaqirish va hisobini yuritish;
- aholi orasida ko‘z gigiyenasi bo‘yicha suhbatlar o‘tkazish;
- asboblarni dezinfeksiya va sterilizatsiya qilish, sanitariya tartibini saqlash.



Muolaja stolidagi ko‘z tomchilari

Statsionar ko‘z bo‘limida palatalar, muolaja xonasi, bog‘lash xonasi va operatsiya bloki bo‘ladi. Ko‘z shifoxonasining farqi shundaki, bemorlarning ko‘pchiligi ko‘rishi past yoki ko‘zi bog‘langan bo‘lgani uchun yo‘laklarda to‘siqlar qoldirilmaydi, zinapoya chetlari aniq belgilanadi, palatalar yaxshi yoritiladi va xavfsizlik qoidalariga alohida e’tibor beriladi. Hamshira postida navbatchilik jurnali, shifokor varaqalari va tezkor yordam vositalari joylashtiriladi.

Sanitariya tartibi va hujjatlar

Ko‘z kabinetida kuniga kamida ikki marta nam tozalash o‘tkaziladi, xona shamollatiladi, kvars lampa rejaga muvofiq yoqiladi. Hamshira ish kuni boshida dorilarning muddatini, steril materiallarning yaroqliligini va jihozlarning sozligini tekshiradi. Kabinetda quyidagi hujjatlar yuritiladi: bemorlarni qabul qilish jurnali, dispanser hisobi jurnali, muolajalar jurnali, sterilizatsiya jurnali va kuchli ta’sir etuvchi dorilar hisobi. Dispanser guruhidagi bemor kelmay qolsa, hamshira u bilan bog‘lanib, qayta chaqiradi. Bu glaukoma va diabetik retinopatiya kabi ko‘rlikka olib keluvchi kasalliklarda ayniqsa muhim, chunki muntazam nazorat ko‘rishni saqlab qolishga yordam beradi.

Hamshira bemorlar oqimini to‘g‘ri tashkil etadi: shoshilinch holatdagi bemorlar (ko‘z shikasti, kuyish, to‘satdan ko‘rish yo‘qolishi, kuchli og‘riq) navbatsiz qabul qilinadi. Keksa va ko‘rishi past bemorlarga yo‘l ko‘rsatiladi, yozuvlarni o‘qishda yordam beriladi. Bolalar bilan ishlashda o‘yin elementlaridan foydalaniladi, ota-onalar tekshiruv jarayoni bilan tanishtiriladi. Kabinet devorlarida

koʻz gigiyenasi va kasalliklarning oldini olish boʻyicha sanitariya byulletenlari joylashtiriladi.

2. Oftalmologik bemorlarni tekshirish usullari va hamshiraning ishtiroki

Tekshiruv shikoyat va kasallik tarixini aniqlashdan boshlanadi, keyin koʻrish funksiyalari va koʻzning obyektiv holati oʻrganiladi. Shifokor bemorni tekshirishdan oldin hamshira xonani va kerakli jihozlarni tayyorlaydi, tekshiruv davomida esa bemor ahvolini kuzatadi va uni ruhan qoʻllab-quvvatlaydi. Bemorni toʻgʻri tayyorlash tekshiruv muvaffaqiyatli oʻtishiga yordam beradi.

Tashqi koʻrik

Tashqi koʻrik kunduzgi yorugʻlikda oʻtkaziladi. Qovoqlar, kipriklar, koʻz tirqishi, koʻz yoshi nuqtalari, koʻz olmasining joylashuvi va harakati baholanadi. Kon'yunktivani koʻrish uchun pastki qovoq pastga tortiladi, yuqori qovoq esa agʻdariladi. Koʻz yoshi xaltachasi sohasi bosib koʻriladi: yiring chiqishi dakriotsistitga xos.

Yon (fokal) yoritish

Qorongʻi xonada stol lampasi bemorning chap tomoniga, koʻz balandligida qoʻyiladi. Tekshiruvchi 13 dioptriyali lupa yordamida nurni koʻzning oldingi qismiga fokuslaydi. Bu usul bilan kon'yunktiva, sklera, shox parda, oldingi kamera, rangdor parda, qorachiq va gavharning oldingi yuzasi koʻriladi. Ikki lupali (binokulyar) usulda kattalashtirish yanada oshadi.

Oʻtuvchi nur bilan tekshirish

Lampa bemorning chap tomoniga va orqaroqqa qoʻyiladi. Tekshiruvchi oftalmoskop koʻzgusidan nurni qorachiqqa yoʻnaltiradi. Normal koʻzda qorachiq bir tekis qizil ravshanlanadi, bu nurning koʻz tubidan qaytishi bilan bogʻliq. Shox parda, gavhar yoki shishasimon tanadagi xiralanishlar qizil fonda qora dogʻlar shaklida koʻrinadi. Shu tariqa koʻzning tiniq muhitlari baholanadi.

Oftalmoskopiya va biomikroskopiya

Oftalmoskopiya koʻz tubini koʻrish usuli boʻlib, koʻruv nervi diski, sariq dogʻ va toʻr parda tomirlari tekshiriladi. Teskari oftalmoskopiyada koʻzgu oftalmoskop va +13 dioptriyali lupa, toʻgʻri oftalmoskopiyada elektr oftalmoskop ishlatiladi. Qorachiqni kengaytirish zarur boʻlsa, shifokor koʻrsatmasi bilan midriatik tomiziladi; glaukomaga shubha boʻlganda bunday qilinmaydi. Biomikroskopiya tirqishli lampada bajariladi: koʻzning oldingi boʻlimi kattalashtirilgan holda aniq koʻrinadi. Hamshira bemorni apparat oldiga toʻgʻri oʻtqazadi, iyak va peshona tayanchini moslaydi, tayanchlarni dezinfeksiya qiladi.

Ko‘z ichi bosimini aniqlash

Taxminiy (palpator) usulda bemor pastga qaraydi, tekshiruvchi ikki ko‘rsatkich barmog‘i bilan yuqori qovoq ustidan ko‘z olmasini navbatma-navbat yengil bosadi. Bosim oshsa ko‘z qattiq, pasaysa yumshoq seziladi. Natija T shaklida yoziladi: Tn norma, T+1, T+2, T+3 oshgan, T−1, T−2, T−3 pasaygan. Aniq usulda Maklakov tonometri ishlatiladi: bemor yotqiziladi, og‘riqsizlantiruvchi tomchi tomiziladi, 10 g li tonometr bo‘yalgan maydonchasi bilan shox parda markaziga qo‘yiladi va izning diametri qog‘ozda o‘lchanadi. Norma 18–26 mm simob ustuni.

Ko‘ruv maydoni, rang va binokulyar ko‘rish

Ko‘ruv maydoni perimetrda yoki taxminiy nazorat usulida tekshiriladi. Rang ko‘rish Rabkin polixromatik jadvallari bilan aniqlanadi. Binokulyar ko‘rish Sokolov sinamasi bilan tekshiriladi: bemor bir ko‘zi bilan naychadan qaraydi, ikkinchi ko‘z oldiga kaftini qo‘yadi. Binokulyar ko‘rish normal bo‘lsa, kaftda “teshik” ko‘rinadi. Qorong‘ilikka moslashish adaptometr bilan o‘lchanadi.

Tekshiruv natijalarini qayd etish

Barcha natijalar ambulator kartaga har bir ko‘z uchun alohida yoziladi: OD – o‘ng ko‘z, OS – chap ko‘z. Avval ko‘rish o‘tkirligi, keyin refraksiya, ko‘z ichi bosimi, tashqi ko‘rik, oldingi bo‘lim va ko‘z tubi holati bayon etiladi. Normada qovoqlar tinch, kon’yunktiva och pushti va yaltiroq, shox parda tiniq, oldingi kamera o‘rtacha chuqurlikda, rangdor parda naqshi aniq, qorachiq yumaloq va yorug‘likka javob beradi, gavhar tiniq deb yoziladi. Normadan har qanday og‘ish aniq tasvirlanadi: joyi, kattaligi, rangi va chegaralari.

Tekshiruv paytida hamshira bemor ahvolini kuzatadi. Ayrim bemorlarda tomchilar yoki yorug‘lik ta’sirida bosh aylanishi, ko‘ngil aynishi, hushdan ketish kuzatilishi mumkin. Bunday holatda tekshiruv to‘xtatiladi, bemor yotqiziladi va shifokorga xabar beriladi. Og‘riqsizlantiruvchi tomchi tomizilgan bemorga 15–20 daqiqa ko‘zini ishqalamaslik tushuntiriladi, chunki sezgirlik kamaygan shox pardani shikastlash oson. Tonometriyadan keyin kon’yunktiva bo‘shlig‘iga dezinfeksiyalovchi tomchi tomiziladi va bo‘yoq qoldiqlari yuviladi.

3. Davolashda hamshiralik parvarishi: amaliy muolajalar

Oftalmologik bemorni davolashda hamshira shifokor buyurgan muolajalarni bajaradi, bemorni kuzatadi va uni uy sharoitida davolanishga o‘rgatadi. Mahalliy davo asosiy o‘rinni egallaydi, umumiy davoda esa antibiotiklar, sulfanilamidlar, vitaminlar va boshqa dorilar buyuriladi. Quyidagi muolajalar bu mashg‘ulotda mustaqil mashq qilinadi.

E. B. Rabkin polixromatik jadvali bilan rang ko‘rishni tekshirish

Jihozlar: Rabkin jadvallari, ko‘rsatgich, qayd varag‘i

1. Bemorni deraza tomonga orqasi bilan o‘tqazing: jadvallar kunduzgi yorug‘likda yaxshi yoritilishi kerak.

2. Jadvalni bemor ko‘zi balandligida 1 m masofada vertikal tuting.
3. Ko‘rsatgich bilan jadvaldagi raqam yoki shaklni ko‘rsating, har biriga 5–10 soniya bering.
4. Bemor javoblarini qayd eting, har bir ko‘zni alohida yoki ikkala ko‘zni birga tekshiring.
5. Natijani baholang: barcha jadvallar to‘g‘ri o‘qilsa, normal trixromaziya.
6. Xatolar bo‘lsa, ularni shifokorga ma’lum qiling va hujjatga yozing.

Kon’yunktiva bo‘shlig‘iga tomchi dori tomizish

Jihozlar: steril pipetka, dori, steril tampon, antiseptik
1. Qo‘lni yuving, antiseptik bilan ishlov bering.
2. Dori nomi, foizi, muddati va ko‘zni tekshiring.
3. Bemorning boshini orqaga egdiring, yuqoriga qarashini so‘rang.
4. Pastki qovoqni tampon bilan pastga torting.
5. Pipetka uchini tekkizmasdan pastki o‘tish burmasiga 1–2 tomchi tomizing.
6. Ko‘zning ichki burchagini 1–2 daqiqa bosib turing.
7. Ortiqcha dorini arting, muolajani qayd eting.

Qovoq orqasiga malham qo‘yish

Jihozlar: ko‘z malhami, steril shisha tayoqcha, steril tampon
1. Shisha tayoqchaning kengaygan uchiga malhamdan oling.
2. Pastki qovoqni pastga torting, bemor yuqoriga qaraydi.
3. Tayoqchani o‘tish burmasiga gorizontal joylashtiring.
4. Bemorga ko‘zni yumishni ayting va tayoqchani tashqi burchak tomon asta tortib oling.
5. Qovoq ustidan yengil uqalab, malhamni taqsimlang.

Ko‘zga monokulyar bog‘lam qo‘yish

Jihozlar: steril doka salfetka, paxta qatlami, bint 5–7 sm
1. Bemorga muolajani tushuntiring, ko‘zni yumishni so‘rang.
2. Ko‘zga steril salfetka va paxta qatlamini qo‘ying.
3. Bintni peshona atrofidan ikki marta aylantirib mahkamlang.
4. Bintni ensa orqali, kasal ko‘z tomondagi quloq ostidan o‘tkazib, ko‘z ustidan qiyshiq olib chiqing.
5. Aylanma va qiyshiq yo‘nalishlarni navbatlab, ko‘zni to‘liq yoping.
6. Oxirini peshona atrofida mahkamlang: bog‘lam quloqni bosmasligi kerak.

Fizioterapiya va qo‘shimcha davolash

UVCh terapiya yallig‘lanish kasalliklarida, masalan govmichcha boshlanishida qo‘llaniladi; davo seansi 4–15 daqiqa, kursi 10–15 seans. Ko‘zga qon quyilganda va ko‘z o‘smalarida UVCh ruxsat etilmaydi. Issiqlik bilan davolashda quruq issiqlik, isituvchi kompress va grelka ishlatiladi. Yiringlash boshlangan bosqichda isitish man etiladi. Yopishtiriladigan bog‘lamlar (okklyuziya) g‘ilaylikda ambliopiyani davolash uchun keng qo‘llaniladi.

Koʻz protezi qoʻyilgan bemorlarga protezni parvarish qilish oʻrgatiladi: u muntazam yuviladi, kon’yunktiva boʻshligʻiga buyurilgan tomchilar tomiziladi. Oftalmektomiya, ya’ni koʻz olmasini olib tashlash operatsiyasidan keyin bemorga ruhiy yordam alohida ahamiyatga ega. Hamshira bemorga dori qabul qilish tartibini, kuzatuvga kelish vaqtini va ogohlantiruvchi belgilarni yozma shaklda ham tushuntirib beradi. Bajarilgan barcha muolajalar tibbiy hujjatda qayd etiladi.

Bemor va uning yaqinlariga oʻrgatish

Uyda davolanadigan bemorga hamshira amaliy koʻrsatma beradi. Tomchini tomizishdan oldin qoʻl yuviladi, flakon uchi koʻz va kipriklarga tekkizilmaydi, ikki xil tomchi orasida kamida 5 daqiqa kutiladi, malham eng oxirida qoʻyiladi. Dorilarni bolalar yetmaydigan joyda saqlash, ochilgan tomchini muddatidan ortiq ishlatmaslik tushuntiriladi. Glaukoma bilan ogʻrigan bemor tomchilarni belgilangan vaqtda, hatto shikoyat boʻlmasa ham, umr boʻyi muntazam ishlatishi kerak. Keksa bemorlarga yaqinlaridan biri oʻrgatiladi yoki tomchi jadvali katta harflar bilan yozib beriladi.

Hamshira muolajadan keyin bemor holatini baholaydi: ogʻriq, qizarish, koʻrish oʻzgarishi kuzatilsa, qayd etadi. Allergik reaksiya belgilari (qovoq shishi, qichish, toshma) paydo boʻlsa, dori toʻxtatilib shifokorga xabar beriladi. Har bir muolaja vaqti, dori nomi va dozasi shifokor varaqasida belgilanadi. Bajarilmagan muolaja sababi ham yoziladi. Bu parvarish sifatini va bemor xavfsizligini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldasheva F. S., Yusupova M. S., Aripova S. M. Koʻz kasalliklari. – Toshkent: Choʻlpon nomidagi NMIU, 2007.
2. Poʻlatova Sh. A., Aripova G. S., Mirzajonova G. X. va boshq. Kattalarda hamshiralik parvarishi. II qism. – Toshkent, 2012.
3. Bikbov M. M. va boshq. Oftalmologiya: darslik (rus tilida). – Moskva: GEOTAR-Media, 2019.
4. World Health Organization. World report on vision. – Geneva: WHO, 2019.